创新药跨部门评价规则差异与协同治理

王孝炯[1*]，陈海婷[1,2]，刘中全[3]

（1. 中国科学院科技战略咨询研究院，北京 100190；

2. 中国科学院大学公共政策与管理学院，北京 100049；

3. 国家发展和改革委员会创新驱动发展中心，北京 100038）

摘要：创新药须依次接受药监、医保和卫健部门的评价，各环节证据要求能否被企业事先识别，关系研发资源配置与创新成果转化。本文基于“制度逻辑—组织注意力”分析框架，对三部门 2018—2026 年发布的 51 个政策来源的 4 481 条句段进行经人工核验的大语言模型编码，比较五维评价内容的注意力配置，并结合政策条文与访谈资料分析评价对象、比较药品与结论用途。研究发现：药监局在安全性与有效性维度的注意力占比合计为 68.38%，医保局在经济性维度为 76.48%，该格局在多种稳健性检验下保持稳定；卫健委在安全性与经济性维度的注意力占比较高，但二者排序受联合发文影响；药监局在创新性维度的注意力占比（20.96%）明显高于医保局（5.84%）和卫健委（3.94%）；同一维度下，三部门的评价对象、比较药品与结论用途不同。跨部门协同为科技创新提供的确定性，在于企业能够在研发阶段知悉各环节的证据要求，而非评审结果的事先确定。据此从前置沟通、补充研究统筹和临床应用反馈 3 个方面提出协同路径，以实现创新药评价的质效协同。

关键词：创新药评价；跨部门协同；注意力配置；制度逻辑；创新政策组合；大语言模型

中图分类号：G311；R197　　**文献标识码：**A

Cross-departmental Differences in Innovative Drug Evaluation Rules and Collaborative Governance

WANG Xiaojiong[1*], CHEN Haiting[1,2], LIU Zhongquan[3]

(1. Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;

2. School of Public Policy and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

3. Innovation-driven Development Center, National Development and Reform Commission, Beijing 100038, China)

Abstract: Innovative medicines are evaluated successively by the drug regulatory, medical insurance, and health administration departments, and whether enterprises can identify the evidence requirements of each stage in advance affects the allocation of R&D resources and the translation of innovations. Drawing on an institutional logics–organizational attention framework, this study codes 4 481 passages from 51 policy sources issued by the three departments from 2018 to 2026 using a large language model validated against human coding, compares attention allocation across five evaluation dimensions, and analyzes evaluation objects, comparators, and uses of conclusions on the basis of policy provisions and interview materials. Safety and efficacy together account for 68.38% of the attention allocated by the National Medical Products Administration, and economic value accounts for 76.48% of that allocated by the National Healthcare Security Administration; these patterns remain stable across robustness checks. The National Health Commission allocates relatively more attention to safety and economic value, although their ranking depends on jointly issued documents. The share of attention to innovativeness is markedly higher in the National Medical Products Administration (20.96%) than in the National Healthcare Security Administration (5.84%) and the National Health Commission (3.94%). Within the same dimension, the departments differ in evaluation objects, comparators, and uses of conclusions. The certainty that cross-departmental coordination

offers to innovation lies in enabling enterprises to know the evidence requirements of each stage during R&D rather than predetermining review outcomes. Three coordination pathways are therefore proposed: early communication, coordinated supplementary studies, and feedback from clinical use, so as to achieve quality–efficiency coordination in the evaluation of innovative medicines.

Key words: innovative drug evaluation; cross-departmental coordination; attention allocation; institutional logics; innovation policy mix; large language model

基金项目：国家自然科学基金面上项目“中国新兴产业创新政策组合的绩效影响机制研究”（72074204）

0 引言

创新药是生物医药领域科技创新成果的重要载体，从获批上市到纳入医保、进入临床，须依次接受国家药品监督管理局（以下简称“药监局”）、国家医疗保障局（以下简称“医保局”）和国家卫生健康委员会（以下简称“卫健委”）的评价，各环节依据不同规则对同一产品作出判断。“十五五”规划纲要提出优化创新药审评审批、健全医保支持创新药发展机制并支持创新药临床使用[1]，《支持创新药高质量发展的若干措施》（以下简称《若干措施》）以全链条支持创新药发展为目标[2]，审评审批、医保准入与临床使用由此被置于同一政策链条之中。在这一链条中，上市审评决定创新药能否进入市场，医保准入影响其支付水平与可及范围，临床使用决定其能否进入医疗机构并惠及患者，三个环节的评价结论共同决定研发投入能否转化为临床价值与市场回报。企业作为研发者和申请人，是贯穿三个环节的证据提交方：药品注册申请人应当为能够承担相应法律责任的企业或者药品研制机构等[3]，医保目录的申报主体为药品上市许可持有人或其授权主体[4]，企业需要在研发阶段生成既能支持上市审批、又能支持支付决策的证据[5]。评价规则是否清晰、能否衔接，因而影响企业在临床研究设计、比较药品选择与证据准备上的安排；Vreman 等综述欧盟监管机构与健康技术评估机构平行科学咨询的既有研究后指出，企业倾向于依据双方反馈调整研发方案中的主要终点和对照选择[6]。2025 年首版商业健康保险创新药品目录（以下简称“商保创新药目录”）与新版基本医保目录同步发布，自 2026 年 1 月 1 日起实施[7，8]。当年基本医保目录新增 114 种药品，其中 1 类创新药 50 种，商保创新药目录纳入 19 种药品[9]；但仍有 10 余个 1 类创新药未通过医保目录专家评审，据新华网报道，国家医保局医药服务管理司负责人表示，部分 1 类新药与目录内同类药品重复且临床价值没有提升，部分药品价格超出“保基本”功能定位或与价值不匹配[8]。这提示，上市审评与医保准入回答的是不同的价值判断问题，企业需要在研发阶段预判后续环节的证据要求。

从创新政策组合的视角看，上述问题的实质是跨部门评价规则能否为企业提供稳定、可预期的制度环境。Flanagan 等[10]以英格兰西北区域为例指出，影响创新的政策组合在很大程度上由卫生等非创新领域政策驱动，而评估和治理这一更广泛组合的机制大多缺位。药监局、医保局和卫健委的评价目的与比较药品各有侧重：获批上市的 1 类创新药未必满足医保评审对临床价值的要求[8]，课题组访谈（见第 3.2 节）亦反映，纳入医保目录的药品在医疗机构的配备使用中可能受阻。若各环节所依据的证据及其用途缺乏清晰界定，企业难以判断既有研究能够支撑哪些结论、后续还需补充哪些证据，规则的不确定性可能转化为证据准备中的重复投入。因此，跨部门协同

的关键不在于以单一标准取代各部门评价，而在于厘清各环节的证据要求及其适用条件，在保障评价质量的前提下提高证据使用效率，实现创新药评价的质效协同。

鉴于此，本文从创新政策组合的跨部门协同视角出发，构建“制度逻辑—组织注意力”分析框架，对三部门 2018—2026 年发布的涉及创新药上市、准入和使用评价的 51 个政策来源进行编码，并结合政策条文与访谈资料，回答以下两个问题：（1）三部门政策文本对安全性、有效性、经济性、创新性和公平性五维评价内容的注意力配置有何差异？（2）在同一维度下，三部门的评价对象、比较药品与结论用途有何不同，既有评价结论用于后续环节需满足哪些条件，对增强评价规则的可预期性、促进创新药研发与应用衔接有何启示？本文的贡献在于统一比较三个环节的评价规则，并从证据适用条件出发阐释其对企业证据准备的含义。

1 文献综述

1.1 创新药评价与创新政策研究

已有关于创新药评价的研究主要围绕价值评估制度、主体互动与政策工具 3 个层面展开。在价值评估方面，孔繁翠[11]比较英、德、法、加四国的创新药价值评估制度，建议建立附加临床收益评估及分级体系；赵华婷等[12]基于法国经验，主张以临床价值分级与再评价支撑医保目录动态调整；艾丹丹等[13]讨论价值评估的多维属性，主张确定公开透明的价值评价标准，以支持基于价值的定价与支付。在主体互动与政策工具方面，王恩楠等[14]运用演化博弈模型分析医保谈判策略，谭清立[15]基于 2014—2022 年生物医药上市公司数据发现医保谈判政策的实施显著增加了企业创新投入，吕倩鹏等[16]对 65 份国家层面创新药研发政策的量化分析发现政策工具内部结构失衡。这些研究多聚焦医保准入或研发政策等单一环节。科技管理领域的研究为跨环节比较提供了启示：刘仁济等[17]指出，政策工具的使用应与创新价值链相匹配，缺乏整体性设计易导致资源的重复投入；宋娇娇等[18]发现，我国科技评价政策中各机构多以自定规则为主，易致碎片化管理，需加强机构协同。对创新药而言，研发阶段形成的证据能否支撑后续支付与临床应用决策，正是评价规则与创新价值链衔接的具体体现。

1.2 多主体评价差异研究

国际研究表明，比较不同机构的评价结论需区分其评价标准与证据要求。Casilli 等[19]以在意大利申请创新性认定的 189 个药品/适应症为样本，比较法、德、意三国健康技术评估（Health Technology Assessment，HTA）的附加治疗价值评级，发现德法一致率为 82%，意法和意德分别为 52%和 57%；改用综合治疗需求、附加治疗价值与证据质量的意大利创新性认定结论，并限于被认定为完全创新或非创新的品种后，分别升至 72%和 74%。Garau 等[20]针对意大利 19 名患者代表、临床医生和支付方人员的探索性研究发现，临床医生更重视疾病严重性与比较疗效，支付方则更关注未满足需求、比较成本及证据质量。

Källberg 等[21]对欧美药品监管与 HTA 机构 19 名参与者的研究表明，各方对抗生素新颖性的理解不一；上市许可与 HTA 之间缺乏处理有限临床数据的共同做法，而上市许可程序为此所作调

整带来的不确定性，还会传导至 HTA 机构、支付方与医务人员。Mundy 等[22]指出，HTA 对创新的界定与评价尚不统一，创新因素往往隐含于优先排序及药品定价、报销决策之中。国内研究中，李梦颖等[23]基于制度逻辑理论分析医保谈判药品在医疗机构的配备与使用，揭示了国家逻辑、市场逻辑、社会逻辑与专业逻辑之间的矛盾与耦合。Wang 等[5]对监管机构、HTA 机构与企业的调查显示，受访企业均曾寻求早期科学咨询，研究据此提出在保持监管与 HTA 职能分立的前提下衔接流程、尽可能趋同证据要求并提高透明度。上述研究表明，评价差异根植于各方的评价标准、证据要求与制度环境。蔡乾和等[24]在公共科技成果价值评价研究中提出，应对评价对象和任务分型分类、依情境开展分类评价，并对评价结果规范和有限使用。借鉴这一思路，上市审评、医保准入与临床使用可视为针对同一创新成果、服务于不同任务的分类评价，其结论亦应在明确适用条件的前提下使用；药品评价具有法定程序与专门技术规则，本文据此在药品政策条文层面考察这一思路的具体体现。

1.3 研究述评

既有研究已讨论政府在医疗与医保治理中的主动管理角色[25]及健康技术评估在医保目录调整中的应用[26]。国际比较研究多以具体药品的评审结论为对象，考察不同国家 HTA 结论的一致性[19]、监管与 HTA 机构在不确定性判断上的差异[6]及其对新颖性的理解[21]。国内文献则或从医保准入角度讨论创新药价值评估，或从政策工具角度分析研发支持政策；创新政策组合研究亦多集中于治理层级维度，对不同政策领域之间组合的探讨较少[27]。总体上，学界较少在统一评价维度下比较药品注册、医保准入与临床使用主管部门的评价规则，也较少从企业证据准备的角度考察跨环节评价规则的衔接。基于此，本文以三部门评价规则文本为对象，以五维框架比较其注意力配置及维度共现，结合具体条文分析评价对象、比较药品与结论用途，并从证据适用条件出发，探讨增强评价规则可预期性的跨部门协同路径。

2 理论基础与分析框架

2.1 核心概念与理论逻辑

本文以药品注册分类界定创新药。《药品注册管理办法》[3]将中药、化学药和生物制品分别划分为创新药、改良型新药等类别，《化学药品注册分类及申报资料要求》[28]将化学药品 1 类界定为境内外均未上市、含有新的结构明确且具有药理作用的化合物，并具有临床价值的创新药。《若干措施》[2]提出增设商保创新药目录，重点纳入创新程度高、临床价值大、患者获益显著且超出基本医保保障范围的创新药。可以看出，注册分类兼顾化合物新颖性与临床价值，医保支付还考虑患者获益与保障范围。Vreman 等[6]援引既有研究指出，新药获批所依据的受试者和关键试验趋于减少，近年提交美国食品药品监督管理局的试验中逾三分之二未设阳性对照；加之各方对创新的界定与评价不尽一致[22]，创新药的价值判断在各环节之间更难直接互认。除突破性治疗等加快上市程序[3]和商保创新药目录等专门安排外，创新药主要适用通用的药品评价规则，故本文比较三部门评价创新药所依据的政策规则，而不限于以“创新药”命名的文件。相应地，本文所称

“创新药评价”，是指三部门政策文本中适用于创新药上市审评、医保准入和临床使用的评价规则，而非具体品种的评审结论。

三部门分别在创新药研发成果转化为临床应用的三个环节中承担评价职能。上市审评由药监局负责，依据安全、有效和质量可控的要求决定药品能否上市[3]；医保准入由医保局负责，以临床必需、安全有效、价格合理为基本条件决定药品能否纳入目录及其支付范围[29]；临床使用由卫健委通过药事管理、合理用药和药品临床综合评价等规则引导医疗机构的药品遴选、配备与使用[30]。2017 年 10 月中办、国办印发的《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》即统筹部署了审评审批、医保支付与医疗机构使用新药[31]。Wang 等[5]亦将新药上市的主要参与方概括为作为研发者的企业、依据质量、安全性和有效性授予上市许可的监管机构，以及提出报销建议的健康技术评估机构。后续环节的评价结果会反过来影响研发投入：谭清立[15]发现，医保谈判政策的实施显著增加了生物医药企业的创新投入，并从引导效应与补偿效应两方面解释其机制。因此，三部门的评价规则共同构成企业研发决策所面对的制度环境，这是本文以三部门为比较对象的原因。三个环节都涉及对药品安全性、有效性等价值维度的判断，但各环节的政策目标与评价要求不同（表 1），这为以统一维度比较注意力配置在三部门之间的差异提供了基础。

制度逻辑视角有助于解释三部门对创新药价值判断的差异。该视角强调实践、价值和规则与认知、行动及制度环境之间的关联，并关注多种制度逻辑之间的冲突与一致如何影响组织行为；医疗卫生领域即同时受市场逻辑、国家逻辑和医学专业逻辑塑造[32]。Flanagan 等[10]亦指出，政策组合中工具之间张力的可能来源包括政策理念、目标与实施方式的冲突。在创新药领域，上述三个环节服务于不同的决策目标，又作用于同一创新产品，使企业面临多重制度要求。本文据此考察这些目标在评价对象、比较药品与结论用途上的具体体现。

制度逻辑揭示了三部门决策目标的差异，而这种差异如何转化为政策文本注意力配置的差异，可由注意力基础观加以解释。Thornton 和 Ocasio[32]指出，制度逻辑使决策者的注意力集中于与主导逻辑相一致的议题和解决方案。Ocasio[33]认为，决策者的行为取决于其关注的议题与应对方案，关注内容随情境变化（情境注意力）；情境本身又取决于组织的规则、资源与社会关系如何分配议题、应对方案与决策者（注意力的结构性分配）。练宏[34]指出，注意力分配是组织环境、制度环境和社会环境的产物；李梦颖等[23]在分析国谈药落地时，为国家、市场、社会和专业逻辑分别界定了注意力分配取向。政府部门同样是组织，政府注意力研究已将同级政府各职能部门之间注意力分配的比较列为研究方向[35]；本文据此将药监局、医保局和卫健委作为组织层面的分析单位。由于三部门的决策情境及规则与资源约束不同，其政策文本对五维评价内容的注意力占比可能存在差异。

政策文本的内容选择为测量上述差异提供了途径。政策文本是政策思想的载体，反映政府决策的理念与动机，且资料相对最易获取[35]；对企业而言，公开的政策文本也是获知各部门评价要求的主要渠道，《目录调整申报指南》（以下简称《申报指南》）即明确申报材料是形式审查和专家评审的主要参考[4]。政府注意力还可通过决策主体偏好与组织行为加以测量[35]，评审中的具体权重与裁量未必在文本中完全呈现，因此本文测量的是各部门通过公开规则向企业传达的评价

重点。政策文本分析是测量政府注意力最常用的方法，可通过词汇、句段和主题等要素量化注意力配置[35]：文宏[36]以关键词所在句段及其语境测量基本公共服务注意力；陈星平等[37]按同一句段在同一维度计一次、在不同维度分别计数的原则比较关注内容的构成。借鉴上述做法，本文将五维评价内容的注意力占比在三部门之间的差异界定为注意力配置差异，并以“注意力占比”衡量，即某维度编码为1的句段数占该部门五个维度编码为1的句段数之和的比例；同一句段可计入多个维度，但在同一维度至多计一次。在比较注意力配置的基础上，本文进一步结合条文与访谈，考察同一维度下证据要求及其用途的差异，以识别跨环节证据准备中需要协调的具体事项。其中，注意力占比反映注意力在部门内部的结构性分配，维度共现则反映同一维度在具体决策情境中与其他维度的关联。

2.2 三部门制度逻辑与研究预期

借鉴李梦颖等[23]按目标取向刻画医药领域各制度逻辑的思路，本文依据三部门核心文件的政策目标概括其制度逻辑。《药品注册管理办法》[3]要求保证药品安全、有效和质量可控，并明确临床价值导向，体现科学—安全逻辑。《基本医疗保险用药管理暂行办法》[29]（以下简称《暂行办法》）将提高基金使用效益列为制定目的之一，并以临床必需、安全有效、价格合理为纳入目录的基本条件，体现经济—效率逻辑。《药品临床综合评价管理指南（2021年版 试行）》[30]（以下简称《管理指南》）强调保障基本用药供应、规范使用并满足用药需求，体现公共服务逻辑。三种逻辑是对各部门主导决策取向的概括，并非与 Thornton 和 Ocasio[32]所列制度秩序一一对应；三者彼此并不排斥，安全有效与临床价值是三部门共同关注的基础（表1、图1）。据此提出预期：药监局在安全性与有效性维度的注意力占比较高，医保局在经济性维度的注意力占比较高，卫健委在安全性与公平性维度的注意力占比相对较高。

表1 创新药评价中的三种制度逻辑

制度逻辑	对应部门	政策目标	评价要求	比较问题
科学—安全逻辑	药监局	保证安全、有效 和质量可控	以临床价值为导向； 提供相应证据	证据如何支持 上市决策
经济—效率逻辑	医保局	提高基金使用效益	临床必需、安全有效、 价格合理	评价结论如何用于 准入和支付
公共服务逻辑	卫健委	保障供应、规范使用， 满足用药需求	安全性、有效性、经济性、 创新性、适宜性、可及性	综合评价如何 指导临床使用

资料来源：作者整理。

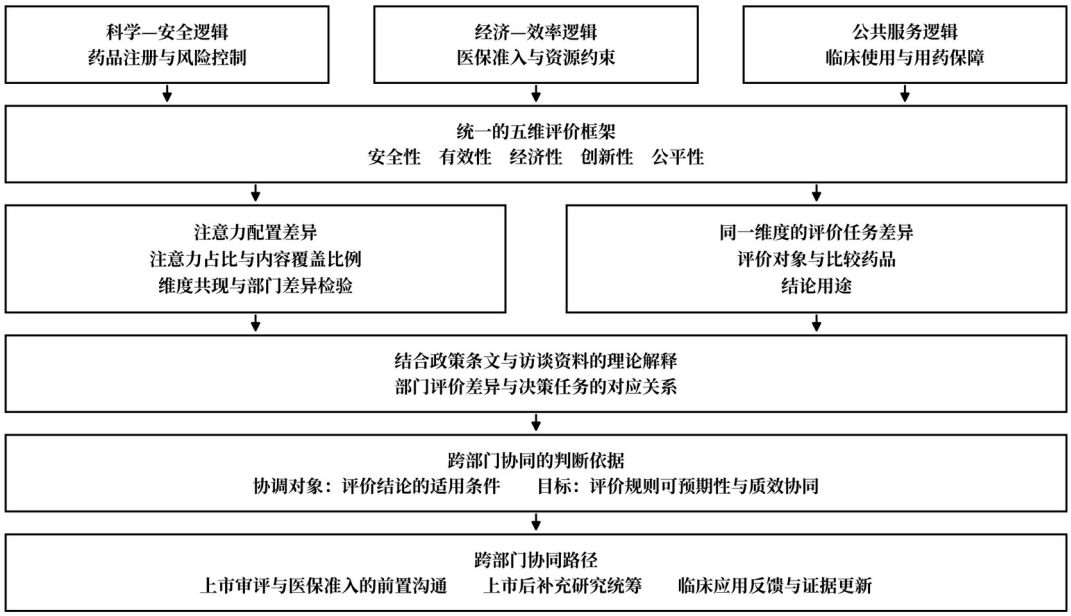


图1 “制度逻辑—组织注意力”分析框架

资料来源：作者绘制。

2.3 跨部门协同的判断依据

制度逻辑与注意力基础观解释了部门评价差异的来源，但未回答差异应如何协调。创新政策组合研究为此提供了判断依据：政策组合要素的一致性从“不存在矛盾”延伸至“形成协同”[38]，多主体治理下的协调则是行动者之间的相互调适，而非由单一决策者统一安排[10]；科技评价研究亦主张分类评价，并对评价结果规范和有限使用[24]。据此，本文界定以下核心概念。比较药品指各评价环节中与目标药品进行比较的药品，包括临床试验的阳性对照药（以下简称“试验对照药”）、医保目录调整的参照药（以下简称“医保参照药”）和临床综合评价的参比药（以下简称“临床参比药”）。适用条件指既有证据及评价结论用于其他环节时须核对的前提，包括评价对象（所评价的药品属性及其目标人群与适应症）、比较药品和结论用途。Rogge 和 Reichardt[38]沿用既有研究的界定，将可预期性视为政策工具的设计特征之一，即工具总体方向、具体规则与时序的确定程度，并指出其影响长周期研发投资面临的不确定性；本文据此将评价规则可预期性界定为企业在研发阶段识别各环节证据要求及既有证据适用条件的程度。跨部门协同为科技创新提供的确定性，即指评价规则可预期性的提高。质效协同指在保障评价质量（即各部门依法独立作出判断及其所需的证据质量）的前提下提高证据使用效率，即让既有证据在适用范围内得到充分利用、减少重复论证。相应地，本文将跨环节评价的协调对象界定为评价结论的适用条件，而非评价标准本身。由此，分析框架在以制度逻辑与组织注意力解释三部门评价差异的基础上，以适用条件为协调对象、以评价规则可预期性和质效协同为目标，推导跨部门协同路径（图1）。

3 研究设计

3.1 政策文本选择

研究时段为 2017 年 1 月至 2026 年 7 月，研究对象为公开的药品评价政策及配套官方材料。由于第 2.1 节所述的 2017 年两办意见[31]统筹部署了审评审批、医保支付与医疗机构使用新药，本文以 2017 年作为检索起点，该意见列入共同制度背景文件。按下述纳入条件筛选后，三部门来源中最早的一份发布于 2018 年，因此纳入的三部门来源发布于 2018—2026 年。

参照吕倩鹏等[16]以部门官网与北大法宝相结合检索、剔除无实质内容和重复文件的做法，以“创新药”“合理用药”“双通道”“药品注册”“药品审评审批”“医保药品目录”“药品临床综合评价”为标题关键词，在北大法宝 V6 中央法规数据库精确检索 2017 年 1 月至 2026 年 7 月的部门规章、部门规范性文件和部门工作文件（检索截至 2026 年 7 月 6 日），并从相关部门官网补充附件及配套材料；标题不含上述关键词的国家药品监督管理局药品审评中心（以下简称“药审中心”）技术指导原则、目录调整配套规则及合理用药管理文件，均属此类补充材料。在此基础上，剔除纯药品清单、年度审评报告、按疾病诊断相关分组和按病种分值付费的技术规范、逐年临床用药手册，以及已有正式版的征求意见稿。

最终纳入 51 个政策来源，其中药监局 17 个、医保局 24 个、卫健委 10 个（示例见表 2，完整清单见补充材料 B）；党中央、国务院或中办、国办发布的 4 份文件作为共同制度背景。一个政策来源可包含通知、附件或配套官方问答，同一正文重复发布仅计一次；联合发文按制度系统归属计入一个部门，并通过剔除联合发文来源检验该处理的影响。卫健委对创新药临床使用的评价主要通过适用于全部药品的药事管理、处方审核、合理用药和临床综合评价规则实现，本文将其作为创新药进入临床使用时所适用的规则加以比较。纳入来源包含适用于全部药品的文件；在全部纳入来源中，含“创新药”一词的句段药监局为 98 条、医保局为 144 条，卫健委为 0 条。

表 2　三部门政策来源示例

部门	名称	文号	发文日期
药监局	药品注册管理办法	国家市场监督管理总局令第 27 号	2020 年 1 月
	优化创新药临床试验审评审批试点工作方案	国药监药注〔2024〕21 号	2024 年 7 月
	…	…	…
	罕见疾病创新药物研发鼓励试点计划（“关爱计划-延伸”）	药审业〔2026〕177 号	2026 年 5 月
医保局	基本医疗保险用药管理暂行办法	国家医疗保障局令第 1 号	2020 年 7 月
	关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见	医保发〔2021〕28 号	2021 年 4 月
	…	…	…
	支持创新药高质量发展的若干措施	医保发〔2025〕16 号	2025 年 6 月
卫健委	医疗机构处方审核规范	国卫办医发〔2018〕14 号	2018 年 6 月
	关于开展药品使用监测和临床综合评价工作的通知	国卫药政函〔2019〕80 号	2019 年 4 月
	…	…	…
	关于改革完善基层药品联动管理机制扩大基层药品种类的意见	国卫药政发〔2024〕38 号	2024 年 11 月

注：表中仅列示部分来源；联合发文按制度系统归入一个部门。

资料来源：作者整理。

3.2　访谈资料

访谈资料为课题组整理的 4 份纪要：专家访谈纪要（I01）、医保专家调研纪要（I02）、企业座谈会纪要（E01）和企业研讨会纪要（E02）。I01 和 I02 的受访者知情并口头同意匿名引用，E01 和 E02 经课题负责人同意匿名使用。I01 涉及医保准入评审的机制与流程、医保体系存在的问题及政策建议；I02 涉及目录评审分层、临床价值评价及流程优化；E01 和 E02 记录了企业对医保准入规则、参照药选择及医疗机构准入的意见。药品监管环节主要依据公开技术文件。访谈内容与相应政策条文相互印证，仅用于阐释评价要求及跨环节实施问题，不用于检验研究结论。

3.3　编码方案

本文采用医保目录调整中的安全性、有效性、经济性、创新性、公平性五维框架。《申报指南》[4]要求申报摘要按基本信息及安全性、有效性、经济性、创新性、公平性组织（经济性限目录内申报药品提供），同时适用于基本医保目录和商保创新药目录申报；《常用问答（2026 年版）》[39]（以下简称《常用问答》）亦要求多维度综合研判药品价值。本文以该框架为统一尺度，依据各部门条文的实质内容编码，以识别药监局获益风险评价和卫健委临床综合评价中的对应内容；统一尺度仅用于描述注意力配置，不意味着三部门应采用相同的标准或权重。《管理指南》[30]原设六个维度，其中药品获取保障与可负担性内容归入公平性，适宜性按原政策含义处理；《申报指南》公平性栏目中的价格信息编码为经济性，同时涉及患者负担或获取保障的另记为公平性。

本文同时采用自动规则编码（以下简称“规则编码”）与大语言模型（Large Language Model，LLM）编码处理全部文本。规则编码基于领域词典与语境规则，识别表述的药品指向、

适用范围及否定关系；LLM 编码采用 GPT-6.1 Sol 模型，依据完整编码手册并结合必要上下文给出五维判断与原文依据，编码时不提供人工标签或其他机器结果，运行设置见补充材料 A。两种方法使用相同的政策原文、五维定义与纳入、排除条件。

本文以具有完整政策含义的句段为分析单元，并保留上级条款、表头及前后文，以确定表述对象与适用条件。三部门共计 4 481 条句段，其中药监局 1848 条、医保局 2 100 条、卫健委 533 条。同一句段可同时编码多个维度，如“降低患者用药负担”同时编码为经济性和公平性，而降低申报费用则不编码为公平性。

3.4 变量与指标

本文将五个维度分别记为 S、E、Ec、I、F。安全性指药物损害与用药风险的识别、评价和控制；有效性指防治效果、临床获益及相应证据；经济性指药品价格、费用、支付与成本效果；创新性指技术创新、实质改良及其资格评价和创新研发支持；公平性指患者按治疗需要获得并持续使用所需药品的机会与负担，一般性可及表述不构成编码依据。各维度在句段层面分别编码为 1（正类）或 0；关键原文缺失、指代无法解析或规则存在冲突时记为无法判定，不计入相应分母，详细的纳入、排除条件见补充材料 A。

注意力占比按第 2.1 节定义计算，五维合计为 100%；内容覆盖比例以部门全部句段数为分母，由于同一句段可涉及多个维度，其合计不必为 100%。条件比例指涉及某一维度的句段中同时涉及另一维度的比例，用于刻画维度共现；注意力占比在部门内最高的维度称为该部门的主要关注维度。以安全性句段中同时涉及有效性的比例（记为 E|S）为例，分子为两维均判为 1 的句段数，分母为安全性判为 1 且有效性可判定的句段数。各指标均基于 4 481 条全量编码计算。

3.5 编码质量检验

人工核验在未用于编码方案开发和既往人工核查的 4 006 条句段中抽取，共纳入 466 条：166 条重点类别句段全部核验，另从三个部门各随机抽取 100 条，合计药监局 106 条、医保局 202 条、卫健委 158 条。重点类别涵盖药监局的经济性内容及医保局、卫健委的安全性和公平性内容，以加强对稀少类别的检验。两名编码员（一名为参与编码手册设计的作者，另一名为未参与设计、经统一培训的同课题组研究生）在不查看机器编码结果的情况下，对照原文及必要上下文独立判读全部句段的五个维度，分歧经讨论后定稿，共形成 2 330 项 0/1 人工标签。

参照 Grimmer 和 Stewart[40]针对具体研究任务开展验证的原则及 Gilardi 等[41]对照机器与人工标注的做法，本文按维度报告 Cohen κ 系数[42]、精确率、召回率及 F1 值，各指标仅在机器与人工均可作二元判断的项目上计算。两名编码员独立判读的 κ 在安全性、有效性、经济性、创新性和公平性上依次为 0.919、0.925、0.947、0.896 和 0.765，2 330 项中有 58 项不一致；按 Landis 和 Koch[43]的标准，κ 为 0.61～0.80 表示高度一致，0.81～1.00 表示几乎完全一致。比较结果见表 3。

表 3　两种编码方法与 466 条句段人工标签的比较

维度	方法	κ	精确率	召回率	F1
安全性	LLM	0.938	0.923	0.992	0.956
安全性	规则	0.706	0.913	0.672	0.774
有效性	LLM	0.960	0.948	0.989	0.968
有效性	规则	0.771	0.983	0.682	0.806
经济性	LLM	0.892	0.864	0.982	0.919
经济性	规则	0.699	0.943	0.629	0.754
创新性	LLM	0.938	0.892	1.000	0.943
创新性	规则	0.982	0.968	1.000	0.984
公平性	LLM	0.880	0.821	0.979	0.893
公平性	规则	0.799	1.000	0.689	0.816
五维合并	LLM	0.926	0.897	0.988	0.940
五维合并	规则	0.765	0.951	0.690	0.799

注：各维均以标签 1 为正类。LLM 编码和规则编码分别有 2 322 项、2 251 项有效二元判断，无法判定 8 项、79 项。五维合并行汇总各维度的真阳性、假阳性、假阴性和真阴性计数。核验样本有意纳入稀少维度的重点类别，表中指标反映核验样本内的一致性，不等同于全量编码的精确率与召回率。各维度可判定项数、无法判定项数及分类计数见补充材料 C。

在 466 条核验样本中，LLM 编码在安全性、有效性、经济性和公平性四个维度的 κ 与 F1 均高于规则编码，仅创新性维度规则编码略高（表 3）。五维合并后，LLM 编码的 κ、F1 与召回率分别为 0.926、0.940 和 0.988，规则编码分别为 0.765、0.799 和 0.690，后者仅精确率略高（0.951 对 0.897）。除创新性外，规则编码其余四个维度的召回率为 0.629～0.689，约三成人工判为 1 的句段未被识别。LLM 编码在经济性和公平性上的精确率相对较低（0.864 和 0.821），故第 4.1 节和第 4.2 节另以规则编码对照。

以同一模型和编码手册对 466 条样本复跑一次（批次组成与并发设置不同于全量运行），两次结果各维度 κ 在 0.926～1.000 之间，438 条句段（93.99%）的五维判断完全一致；复跑结果与人工标签的五维合并 κ 为 0.929（原结果为 0.926），各维度 κ 在 0.876～0.954 之间，表明 LLM 编码具有较好的可重复性。

综合各维度 κ、F1 及具体判读结果，本文以 LLM 编码作为部门比较的主要依据；创新性维度两种方法的 κ 均高于 0.93，为统一五维口径亦采用 LLM 结果。规则编码作为方法对照，用于检验主要结论是否随编码方法而改变。

3.6　统计分析

各维度内容覆盖比例采用 3×2 卡方检验并报告 Cramér's V（3×2 列联表中 V 与 w 相等，以 0.10、0.30 和 0.50 为小、中、大效应参考值[44]）。内容覆盖比例的部门两两比较和条件比例比较采用 Fisher 确切概率法并作 Bonferroni 校正，以校正后 P<0.05 为差异具有统计学意义。注意力占比、条件比例及其部门差异在部门内以政策来源为单位整群重抽样 5 000 次[45]，估计 95%置

信区间（confidence interval，CI）。考虑到同一来源的句段并非相互独立，部门差异是否稳定以按来源重抽样的 95%CI（表 6）为主要依据，Fisher 确切概率法结果作为句段层面的补充，二者不一致时只报告差异方向，不作稳定差异的判断；置信区间未作多重比较校正，句段重抽样区间及完整检验结果见补充材料 F。

稳健性分析包括三类：一是九种统计口径，涵盖条款等权、精确重复降权、剔除联合来源、剔除年度系列或多组件来源、限定 2018—2025 年完整自然年及来源等权等处理；二是逐一剔除 51 个政策来源；三是无法判定项的边界分析，即令无法判定的维度在 0 与 1 之间取值，计算条件比例的上下界（补充材料表 D2）。各口径定义与结果分别见补充材料 A 和 D，两种编码方法的全量对照见补充材料 E。

4　研究结果与分析

本部分依次报告四方面内容：4.1 节比较三部门在五个维度上的注意力占比，说明各部门关注什么；4.2 节考察维度共现及其对应的条文内容，说明各维度在部门内如何组合；4.3 节比较同一维度下的评价对象、比较药品与结论用途，说明同一维度服务于何种决策；4.4 节结合理论对上述结果作出解释。其中，4.1 节和 4.2 节基于 4 481 条句段的全量编码，4.3 节基于政策条文与访谈资料。

4.1　注意力配置差异

LLM 编码（全量）结果显示，药监局在安全性与有效性维度的注意力占比合计为 68.38%；医保局在经济性维度的注意力占比为 76.48%；卫健委在安全性（39.37%）与经济性（28.35%）维度的注意力占比较高（表 4、图 2）。药监局在创新性维度的注意力占比为 20.96%，明显高于医保局（5.84%）和卫健委（3.94%），相关内容主要涉及创新药注册分类、临床价值导向和研发支持（表 5）。描述性地看，含“创新药”一词的句段中，药监局 98 条句段在创新性和安全性维度的注意力占比分别为 45.35%和 29.07%，医保局 144 条句段在经济性和创新性维度分别为 41.67%和 22.92%，卫健委文本无此类句段；两部门此类句段在创新性维度的注意力占比均高于各自全部句段，但医保局仍以经济性维度的注意力占比居首。按是否为专门针对创新药的来源拆分后，两部门的主要关注维度均与全部来源一致，其中药监局其他来源在安全性与有效性维度的注意力占比几乎持平（表 7）。

表 4　三部门五维注意力占比/%

部门	结果	安全性	有效性	经济性	创新性	公平性
药监局	LLM 全量	40.44	27.94	0.46	20.96	10.20
医保局	LLM 全量	6.97	6.97	76.48	5.84	3.75
卫健委	LLM 全量	39.37	16.54	28.35	3.94	11.81

注：本表为 LLM 全量编码结果。分母为本部门五个维度编码为 1 的句段数之和，未舍入的五维占比合计为 100%。LLM 全量编码中无法判定的 60 项不计入。

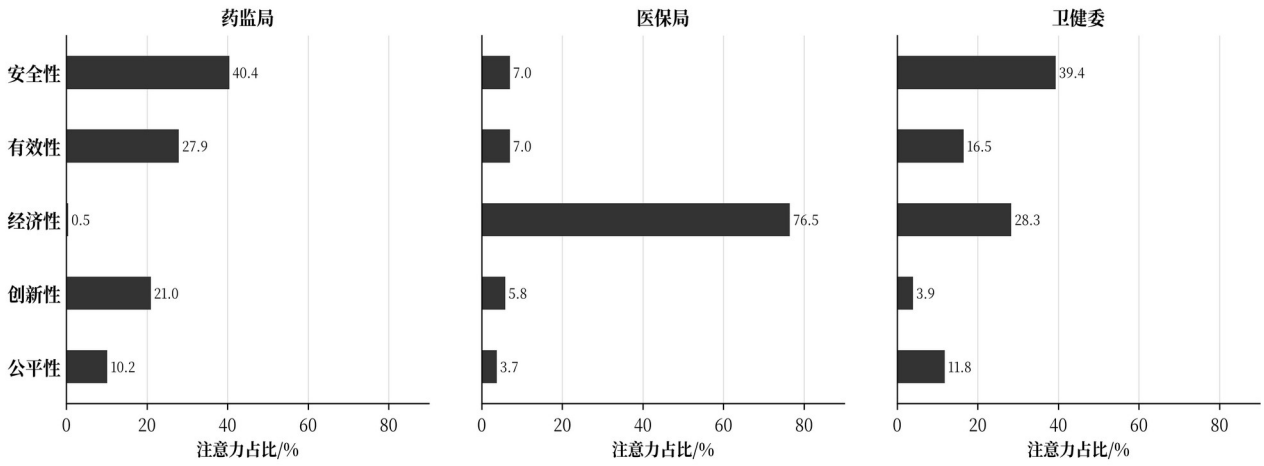


图 2　三部门五维注意力占比

注：口径同表 4，数值保留 1 位小数。

规则编码在经济性和公平性上的精确率较高（表 3），以其对照 LLM 编码得到的注意力配置，结果与 LLM 编码基本一致：药监局在安全性与有效性维度的注意力占比较高，医保局在经济性维度的注意力占比为 76.87%（LLM 编码为 76.48%），卫健委在安全性维度的注意力占比较高。在三部门两两比较的 15 项注意力占比差异中，13 项方向一致，不一致的 2 项为药监局与卫健委在安全性和公平性维度注意力占比上的相对排序。LLM 编码下两部门在安全性维度的注意力占比分别为 40.44%和 39.37%，在公平性维度分别为 10.20%和 11.81%，差距均不足 2 个百分点，且卫健委五维标签仅 127 个，因此不认为两部门在这两个维度上存在稳定的高低关系。三部门五维内容覆盖比例见图 3。

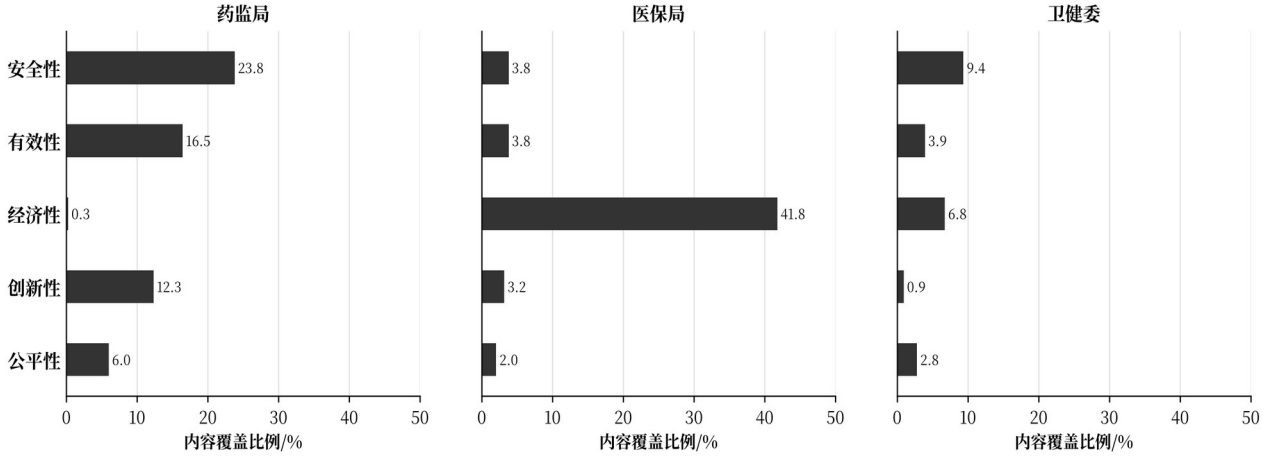


图 3　三部门五维内容覆盖比例

注：本图为 LLM 全量编码结果。分母为各部门全部句段数，五维之和不必为 100%。

图 2 与图 3 的分母不同：医保局经济性句段 878 条，占全部 2 100 条句段的 41.81%（图 3），占五维标签合计 1148 个的 76.48%（图 2）。在九种统计口径及逐一剔除来源后，LLM 编码下药监局在安全性维度、医保局在经济性维度的注意力占比点估计均居首，这一结果保持不变；卫健委按全部句段以安全性维度的注意力占比居首，但剔除联合来源或 2022 年加强用药安全管

理文件后转为经济性维度居首。卫健委 50 条安全性句段中有 29 条来自两份联合发文，即 2022 年加强用药安全管理文件（18 条）和《医疗机构处方审核规范》（11 条）；剔除前者后，安全性与经济性句段分别为 32 条和 36 条，仅保留单独发文来源时为 8 条和 23 条。由此可知，卫健委在安全性维度的注意力占比居首主要源于联合发文，该排序对来源构成较为敏感。

句段层面的检验表明，五维内容覆盖比例的部门差异均具有统计学意义（χ^2=44.44～1107.27，P 均<0.001，Cramér's V 为 0.100～0.498），其中公平性的部门差异效应量较小。医保局在经济性维度的注意力占比与药监局在创新性维度的注意力占比均高于另两部门，按政策来源重抽样的 95%CI 不含 0，且两种编码结果一致。卫健委内部安全性与经济性、药监局内部安全性与有效性的先后则无法确定（表 6）：药监局这两类句段分别集中于安全性总结资料、风险管理计划等技术文件与抗肿瘤药物研发、真实世界证据等指导原则，按来源重抽样时其先后随样本构成而变化。因此，本文不区分二者先后，将安全性与有效性合称为药监局注意力占比最高的两个维度。上述结果刻画了三部门政策文本中五维评价内容的构成，其对创新药证据准备的含义由第 4.3 节结合具体条文进一步揭示。

4.2 维度共现与具体内容

安全性句段中同时涉及有效性的比例（E|S）以医保局最高：LLM 编码下医保局为 81.01%（64/79），药监局为 42.60%（187/439），卫健委为 26.00%（13/50）。医保局与另两部门的差异具有统计学意义，药监局与卫健委的差异未达到统计学意义（表 6），这可能与卫健委分母较小、来源集中导致检验功效有限有关。该结果在规则编码对照与各项稳健性分析中保持不变；按完全相同文本、规范化文本和近似文本（相似度≥0.85）三种方式去除重复援引条款后，医保局 E|S 在 LLM 编码下为 76.74%～81.67%，在规则编码下为 60.00%～70.00%，均高于另两部门（补充材料表 D3）。

政策条文与访谈资料有助于理解这一结果。《暂行办法》第七条将安全有效、临床必需和价格合理共同列为目录准入条件[29]，《申报指南》要求说明创新带来的疗效或安全性优势[4]；I02 将安全性、有效性和经济性列为综合评审的核心内容，I01 所述综合组评价的六个维度亦涵盖上述三项。可见，医保局较少单独论述安全性，而是将其与疗效一并作为准入条件。这提示，仅服务于上市决策的安全性证据，未必能直接回答医保评审中与参照药比较的安全性问题。卫健委该比例较低，主要因其安全性句段多涉及用药错误防范与处方审核流程，在 2022 年加强用药安全管理文件和《医疗机构处方审核规范》中分别仅为 5.56%（1/18）和 9.09%（1/11）。

经济性句段中同时涉及公平性的比例（记为 F|Ec）在 LLM 编码下卫健委（13.89%，5/36）高于医保局（2.96%，26/877），句段层面 Fisher 检验在 LLM 编码下校正后 P=0.017，但按来源重抽样的 95%CI 包含 0，规则编码下未达到统计学意义，且卫健委 5 条共现句段中有 4 条来自《管理指南》，故不将其视为稳定的部门差异（表 6）。以公平性句段为分母（记为 Ec|F）时方向相反，这是因为医保局经济性句段基数较大：医保局为 60.47%（26/43），卫健委为 33.33%（5/15），差异未达到统计学意义。各口径结果见补充材料 D。

表 5　同一评价维度在三部门的具体内容

维度	药监局	医保局	卫健委
安全性	研发和上市环节的药物风险、获益风险评价及控制措施	同类药安全性比较及药品保障渠道中的用药安全	上市前后的安全性证据、处方风险与合理用药
有效性	目标患者的临床获益、试验对照药与终点	与试验对照药及目录内同领域药品比较，明确支付人群	与临床参比药比较实际人群的健康获益，必要时开展亚组分析
经济性	真实世界经济学效益评价、试验供药及检测费用的承担	价格、治疗费、支付范围内费用、基金影响与续约	用于采购和临床资源配置的增量经济分析
创新性	创新药注册分类、临床价值导向及研发支持	创新带来的疗效与安全性优势、产品属性变化	临床需求的满足、治疗空白的填补及自主研发
公平性	优先审评临床急需短缺药品，回应供药需求	目录保障短板、患者获取药品的机会及供应、支付条件	机构药品配备、短缺情况、可获得性与家庭可负担性

资料来源：《药品注册管理办法》[3]、医保用药管理及申报材料[4，29，39]、《管理指南》[30]及对应技术文件。

药监局的安全性与有效性内容主要围绕药品研发及上市所需的获益风险证据展开，如《创新药研发期间风险管理计划撰写技术指导原则（试行）》[46]要求识别影响获益风险平衡或受试者安全的风险，并制定预防、监测和治疗措施。药监局在经济性维度的注意力占比较低，相关内容包括真实医疗实践中的经济学效益评估[47]，以及 2026 年发布的《药物临床试验质量管理规范》[48]第四十五条规定的免费供药与医学检测费用责任；公平性内容主要为《药品注册管理办法》[3]第六十八条对临床急需短缺药品的优先审评安排。

医保局的经济性评价涵盖药价、治疗费用、销量预测、支付范围与基金影响。《申报指南》[4]要求目录内申报药品报告未来两年的销量与基金影响，《谈判药品续约规则》[49]依据实际药品费用与预算之比安排续约及支付标准调整。《若干措施》[2]提出通过协商合理确定商保创新药目录内药品的结算价。卫健委《管理指南》[30]将价格水平、可获得性和可负担性共同纳入可及性评价，并以年用药治疗费用占家庭年可支配收入的比重衡量可负担性；药品监测政策[50]进一步要求共享信息、保障供应并应用评价结果。由此，经济性与公平性的关联主要体现在支付保障、患者可负担性与药品供应等方面。

表 6　部门差异的统计检验

指标	比较	LLM 编码			规则编码		
		差值	95%CI	*P*	差值	95%CI	*P*
经济性维度注意力占比	医保局-药监局	76.02	[67.60, 83.29]	—	76.14	[66.72, 83.49]	—
	医保局-卫健委	48.13	[32.04, 64.88]	—	49.09	[33.10, 66.94]	—
创新性维度注意力占比	药监局-医保局	15.12	[5.28, 26.34]	—	18.42	[5.24, 33.59]	—
	药监局-卫健委	17.02	[6.89, 28.86]	—	19.08	[5.22, 35.65]	—
卫健委内部注意力占比	安全性-经济性	11.02	[−20.00, 55.10]	—	13.33	[−18.18, 56.96]	—
药监局内部注意力占比	安全性-有效性	12.50	[−1.52, 33.86]	—	12.32	[−1.29, 33.84]	—
E|S	医保局-药监局	38.42	[16.20, 60.68]	<0.001	30.14	[6.12, 52.04]	<0.001

指标	比较	LLM 编码			规则编码		
		差值	95%CI	*P*	差值	95%CI	*P*
	医保局-卫健委	55.01	[19.67, 74.07]	<0.001	43.60	[11.40, 63.22]	<0.001
	药监局-卫健委	16.60	[−22.31, 42.62]	0.071	13.46	[−21.18, 40.24]	0.430
F|Ec	卫健委-医保局	10.92	[−3.95, 24.22]	0.017	3.32	[−1.21, 23.94]	0.564
Ec|F	医保局-卫健委	27.13	[−37.84, 68.57]	0.244	5.56	[−11.11, 24.00]	1.000

注：E|S、F|Ec、Ec|F 分别为安全性句段中涉及有效性、经济性句段中涉及公平性、公平性句段中涉及经济性的比例。差值为前项减后项，单位为百分点。95%CI 为部门内按政策来源重抽样 5 000 次的 2.5%和 97.5%分位数（个别比较的有效重抽样次数略少于 5 000 次）。*P* 为双侧 Fisher 确切概率法经 Bonferroni 校正后的 *P* 值，同一条件比例内按 3 次比较校正；注意力占比中同一句段可计入多个维度，标签之间不相互独立，故未作 Fisher 检验，以“—”表示。

表 7　专门针对创新药的来源与句段的五维注意力占比/%

部门	来源范围	句段数	安全性	有效性	经济性	创新性	公平性
药监局	全部来源（17 个）	1 848	40.44	27.94	0.46	20.96	10.20
	专门来源（10 个）	597	52.07	17.62	0.00	25.91	4.40
	其他来源（7 个）	1 251	34.05	33.62	0.71	18.23	13.39
	含“创新药”一词的句段	98	29.07	13.95	0.00	45.35	11.63
医保局	全部来源（24 个）	2 100	6.97	6.97	76.48	5.84	3.75
	专门来源（5 个）	826	6.24	6.90	69.93	10.02	6.90
	其他来源（19 个）	1 274	7.44	7.01	80.69	3.15	1.72
	含“创新药”一词的句段	144	8.33	14.58	41.67	22.92	12.50

注：本表为 LLM 全量编码结果，口径同表 4。药监局专门来源指名称含“创新药”的 10 个来源；医保局专门来源指《若干措施》、2025 年和 2026 年目录调整工作方案、2026 年《申报指南》和《常用问答》5 个来源。卫健委无专门来源，文本中也未出现“创新药”一词，故未列示。各子集标签数及规则编码对照见补充材料表 D4、D5。

4.3　同一维度的评价任务差异

注意力占比与维度共现揭示了政策内容的分布特征，但同一维度仍可能服务于不同评价任务。以下依次比较三部门在评价对象、比较药品与结论用途上的规定（比较药品的含义见第 2.3 节），以明确跨环节使用既有证据时需要核对的事项。

在评价对象上，三部门对药品创新属性的界定口径不同。药监局《化学药品注册分类及申报资料要求》[28]同时考察化合物新颖性与临床价值；医保局要求申报材料说明创新带来的疗效或安全性优势[4]，续约规则将 1 类药品注册分类用于特定条件下的谈判选择[49]；卫健委《管理指南》[30]通过与临床参比药的比较考察药品满足临床需求的程度，并关注治疗空白、未满足需求及自主研发。三部门均重视创新的临床意义，但评价结论分别服务于分类注册与研发支持、支付决策以及医疗机构的药品遴选与配备。I02 指出，获得创新药注册分类并不意味着能够实现企业预期的谈判价格。这意味着，注册分类结论本身不能直接说明药品在医保谈判中的相对临床价值。

在比较药品上，抗肿瘤药物研发指导原则[51]要求试验对照药反映目标患者在临床实践中的最佳治疗选择，并建议收集反映患者获益的临床终点。医保局《申报指南》[4]要求与试验对照药及目录内同治疗领域药品进行比较，《常用问答》[39]进一步明确参照药原则上应为临床应用最广泛

的同治疗领域、同作用机制的目录内药品。卫健委《管理指南》[30]重视临床参比药、最佳可得研究证据及真实世界数据，必要时开展亚组分析。因此，即使针对同一适应症，试验对照药、医保参照药与临床参比药也可能不同；既有试验结果能否直接用于后续环节，取决于其目标人群与适应症（包括治疗线别）及比较药品是否与后续评价一致。E02 记录，企业认为医保评审所用的评估标准与药监局的评估标准不大吻合，多数企业不认可医保谈判所依据的参照药，并希望评分与参照药标准公开更多细节。

在结论用途上，药监局通过获益风险判断支持上市审批与风险控制；医保局通过相对临床价值、药品费用及基金影响评估支持医保准入与支付；卫健委通过安全性、有效性及增量经济分析支持医疗机构的药品遴选、采购使用与资源配置[3，29，30]。结合 I02 关于临床价值分层与经济评价衔接的讨论，经济评价方法虽可用于不同环节，但各项评价需分别明确分析视角、成本范围、适用人群及所服务的决策。因此，不同环节可以共享部分研究材料，但评价结论的含义取决于各自的决策用途。

4.4 理论解释

从制度逻辑视角看，注意力配置在三部门之间的差异与其承担的决策任务相对应。药监局的科学—安全逻辑体现为对获益风险及证据充分性的重视，医保局的经济—效率逻辑体现为对相对临床价值与资源约束的关注，卫健委的公共服务逻辑则体现为对安全合理用药、药品供应与临床需求的重视。对照第 2.2 节的研究预期，药监局和医保局的结果与预期相符。研究预期由三部门核心文件的政策目标推导，而《药品注册管理办法》《暂行办法》和《管理指南》的句段分别为 368 条、109 条和 108 条，仅占各部门语料的 19.91%、5.19%和 20.26%（据补充材料表 B1 计算），结果与预期相符并非由核心文件自身内容所决定。卫健委在安全性维度的注意力占比较高，但该排序主要源于联合发文（第 4.1 节）；其在公平性维度的注意力占比（11.81%）与药监局（10.20%）接近，预期仅得到部分支持。这与其来源构成有关：10 个来源中有 7 个为合理用药、处方审核和医疗质量类文件，合计占其句段的 68.11%；15 条公平性句段中有 9 条来自 2024 年基层药品联动管理文件。李梦颖等[23]指出，国谈药落地与医保部门控费、卫生健康部门合理用药的政策目标部分脱嵌，构成国家逻辑内部的冲突；本文则在三部门评价规则文本中观察到相应的注意力配置差异，将这一分析由政策执行环节延伸至评价规则层面。

从注意力基础观看，如第 2.1 节所述，注意力占比反映注意力在部门内部的结构性分配，维度共现反映具体决策情境中的内容关联。医保局在经济性维度的注意力占比较高，与其基金影响报告、续约支付标准调整等任务相对应[4，49]；其安全性与有效性的高共现表明，在准入情境中安全性多与疗效共同构成判断条件。药监局在创新性维度的注意力占比明显高于另两部门，服务于注册分类与研发支持。这一发现与既有国际研究相呼应。Casilli 等[19]发现，跨国评级差异可能与证据质量的处理方式有关；本文比较的则是同一国家内承担不同决策任务的部门，其差异更多体现在同一维度所对应的比较药品与结论用途上。Vreman 等[6]对美欧监管与 HTA 报告的比较显示，HTA 机构对 88%～100%的药品提出相对比较药品疗效的不确定性，监管机构仅为 12%～

32%；Kållberg 等[21]在抗生素领域指出了上市评价与 HTA 之间的证据衔接困难，与之对应，本文在我国规则层面观察到试验对照药、医保参照药与临床参比药设定上的差异（第 4.3 节）。因此，注意力占比的差异揭示了注意力在各部门内部配置的重点，而同一维度在不同环节承担的不同决策功能，则需结合比较药品与结论用途加以识别。

上述差异意味着，创新药在某一环节形成的评价结论进入下一环节时，需要重新说明其适用条件。医保局申报要求在有效性信息中列明药审中心《技术评审报告》对本药品有效性的描述[4]，表明上市审评证据可为医保评价提供部分依据；卫健委同时评价价格与药品获取情况[30]，将支付条件与医疗机构配备、临床使用相联系。访谈中，I01 反映部分药品纳入医保目录后在医疗机构的配备与使用仍然受限，提示药品的实际应用还取决于医疗机构的临床需求与用药条件。因此，跨部门协同的重点在于明确评价结论的适用条件，即逐项核对评价对象、比较药品与结论用途是否一致，说明既有证据能够回答哪些问题、哪些问题有待补充研究。Vreman 等[6]亦主张，监管与 HTA 机构应在研发阶段共同识别下游评价关注的不确定性，商定所需证据及其生成时点。以适用条件为核心的协同，可在保留各部门独立判断的同时，减少因证据要求不清导致的重复论证。

创新政策组合研究指出，政策的可预期性关系投资者面临的不确定性，对长周期的研发决策尤为重要[38]；评价规则的可预期性因而是企业配置研发资源的重要前提。如第 2.3 节所界定，这里的可预期性指企业能否在研发阶段识别各环节的证据要求及既有证据的适用条件。企业设计临床研究、准备评价材料或安排补充研究时，需要掌握各环节对研究人群、比较药品、观察结果与分析视角的要求。如第 4.3 节所示，企业对评估标准与参照药选择存在明确的信息需求；E01 亦建议建立医保部门与企业的定期对话机制。若跨部门沟通能够尽早说明既有证据的适用条件与待补充的研究，企业即可将证据规划前移，在研发阶段统筹考虑准入与使用的需要。对于可共用的数据，可在质量要求相符的前提下统筹采集，各部门仍依据各自目的作出判断。在此意义上，跨部门协同为创新提供的“确定性”并非对评审结果的事先确定，而是企业能够在研发阶段知悉各环节的证据要求及既有证据的适用条件。这一确定性并不要求各部门事先确定全部证据。现行制度已提供相应渠道：《药品注册管理办法》允许申请人在药物临床试验申请前、临床试验过程中和上市许可申请前等关键阶段与药审中心沟通交流[3]，《若干措施》要求畅通医保部门与创新药企业的沟通交流渠道[2]，参照药预沟通亦已面向符合条件的 1 类药品开展[52]。跨部门协同的重点在于使这些渠道给出的证据要求能够相互参照。在此基础上，各部门保留独立判断以保障评价质量，企业减少重复论证以提高证据使用效率，二者共同构成质效协同的基础。

5 跨部门协同路径与政策建议

基于上述研究发现，围绕增强评价规则可预期性、实现创新药评价质效协同的目标，按研发—准入—使用的顺序提出如下建议。各项建议均以现行制度安排为基础，不改变各部门依法独立作出的评价结论。

5.1 推动上市审评与医保准入的前置沟通衔接

应以比较药品与证据要求为重点，推动药审中心沟通交流意见与医保部门政策指导相互参照，使企业尽早知悉上市审评与医保准入所用比较药品的差异。依托《若干措施》关于上市申请获得受理的创新药可同步申请医保部门点对点政策指导、围绕参照药等开展交流的安排[2]，以及参照药预沟通机制[52]，引导企业在关键临床试验设计阶段说明试验对照药与意向医保参照药的差异；结合药品价格形成机制改革以创新程度和临床价值界定高水平创新药的要求[53]，由企业分别说明注册分类与相对临床价值所依据的证据，医保部门在指导中明确既有上市证据可参照的范围和需要补充论证的问题，减少准入阶段的重复论证。

5.2 统筹上市后补充研究与医保价值评价

应以评价用途为导向统筹上市后补充研究，使上市阶段形成的证据能够回应医保准入中与参照药比较的安全性和有效性要求。依托《药品注册管理办法》对附条件批准药品和上市后研究的要求[3]、真实世界医保综合价值评价试点[54]，以及《若干措施》关于真实世界研究结果用于目录准入、续约和支付范围调整的安排[2]，由医保部门会同药监部门按评价用途明确各品种上市后需要回答的问题；在数据使用权限与质量要求相符的前提下统筹数据采集与随访，药物警戒、医保价值评价与临床综合评价仍依据各自目的分别开展分析；在既有协议范围内明确新增证据用于目录续约和支付范围调整的条件，减少同类数据的重复采集，提高证据生成与使用效率。

5.3 健全临床应用反馈与证据更新机制

应在既有监测中区分创新药未配备或无法使用的原因，使医保准入后的临床适用问题得到识别和分类处理。依托《若干措施》提出的研究制定创新药临床综合评价技术指南、推动创新药配备使用等安排[2]，以及 2025 年目录发布通知明确的药品配备、临时采购与监测责任[7]：属于证据不足的，转化为后续评价需要回答的问题；属于供应与支付的，按现有职责协调解决；属于无适用患者或不具备用药条件的，不以提高使用量为目标。医疗机构、企业和相关部门的反馈信息可用于制定临床综合评价技术指南和开展后续评价，配备与采购信息仅反映应用条件，不替代疗效与安全性证据。由此在研发、准入与使用之间形成证据持续更新的衔接机制。

6 结论与展望

本文基于“制度逻辑—组织注意力”框架，综合运用政策文本编码、条文分析与访谈资料，比较药监局、医保局和卫健委在创新药评价中的注意力配置差异，得出以下结论：第一，三部门政策文本的注意力配置存在差异，药监局在安全性与有效性维度的注意力占比较高，医保局在经济性维度的注意力占比较高，卫健委在安全性与经济性维度的注意力占比较高，但二者排序受联合发文影响；药监局在创新性维度的注意力占比明显高于另两部门；医保局安全性句段中同时涉及有效性的比例（81.01%）明显高于另两部门，表明医保准入将安全性与有效性共同作为判断条件。第二，同一维度下三部门的评价对象、比较药品与结论用途各不相同，既有证据能否用于后续环节，需结合评价对象、比较药品与结论用途加以判断；跨环节使用评价结论时，应说明既有证据

能够支持的判断及仍需补充的问题。这意味着，创新药跨部门协同治理的关键，在于使各环节的证据要求与既有证据的适用条件能够被企业在研发阶段识别和预期。据此，协同治理的落脚点在于：在保障评价质量的前提下提高证据使用效率，即实现质效协同。

本文的边际贡献主要有三方面。一是研究对象上，区别于聚焦医保准入或研发政策单一环节的研究，以及基于具体药品评审结论的跨机构比较[6，19]，本文在统一五维框架下比较药品注册、医保准入与临床使用三个环节的评价规则文本。二是理论上，将制度逻辑分析由医保谈判药品的执行环节[23]延伸至跨部门评价规则层面，并借鉴创新政策组合的一致性[10，38]与科技评价中分类评价、结果有限使用的思路[24]，指出跨环节评价差异的协调对象是评价结论的适用条件，而非评价标准本身。三是实践上，将跨部门协同为科技创新提供的确定性界定为企业在研发阶段对各环节证据要求及既有证据适用条件的知悉，并据此提出前置沟通、补充研究统筹与临床应用反馈三条路径，为在保障评价质量的同时提高证据使用效率、推进创新药研发、准入与使用环节的质效协同提供了可行方向。

本研究的局限主要在于：注意力占比刻画的是政策文本中各维度内容的比重，与评审中的实际权重未必一致[35]；卫健委来源较少且以适用于全部药品的通用规则为主，《管理指南》中的适宜性未作为独立维度统计；企业层面的材料仅来自两场企业座谈与研讨，未对企业的预期与研发投入作系统观测。未来研究可扩充卫健委及地方层面文本、对适宜性单独编码，并结合评审、配备、用药及企业层面的数据，考察政策文本注意力配置与实际执行之间的关系。

参考文献

[1]中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要[Z]. 2026.

[2]国家医疗保障局, 国家卫生健康委员会. 国家医保局 国家卫生健康委关于印发《支持创新药高质量发展的若干措施》的通知：医保发〔2025〕16号[EB/OL]. (2025-07-01)[2026-10-31]. https://www.nhsa.gov.cn/art/2025/7/1/art_104_17058.html.

[3]国家市场监督管理总局. 药品注册管理办法: 国家市场监督管理总局令第27号[Z]. 2020.

[4]国家医疗保障局. 2026年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整申报指南[Z]. 2026.

[5]Wang T, McAuslane N, Goettsch W G, et al. Regulatory, health technology assessment and company interactions: The current landscape and future ecosystem for drug development, review and reimbursement[J]. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 2023, 39(1): e20.

[6]Vreman R A, Naci H, Goettsch W G, et al. Decision making under uncertainty: Comparing regulatory and health technology assessment reviews of medicines in the United States and Europe[J]. Clinical Pharmacology & Therapeutics, 2020, 108(2): 350-357.

[7]国家医疗保障局, 人力资源社会保障部. 关于印发《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录》以及《商业健康保险创新药品目录》（2025年）的通知: 医保发〔2025〕33号[EB/OL]. (2025-12-07)[2026-10-08]. https://www.nhsa.gov.cn/art/2025/12/7/art_53_18971.html.

[8]吴佳佳. 医保商保“双目录”大力支持创新——好药新药加速惠及百姓[EB/OL]. 新华网, (2026-01-03)[2026-10-26]. https://www.news.cn/fortune/20260103/a458cb7c27b3499c823fc43b29777a3e/c.html.

[9]国家医疗保障局. 国家医保局 人力资源社会保障部印发2025年版国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录和商业健康保险创新药品目录[EB/OL]. (2025-12-07)[2026-10-26]. https://www.nhsa.gov.cn/art/2025/12/7/art_14_18972.html.

[10]Flanagan K, Uyarra E, Laranja M. Reconceptualising the ‘policy mix’ for innovation[J]. Research Policy, 2011, 40(5): 702-713.
[11]孔繁翠. 创新药价值评估的国际经验比较及启示[J]. 中国卫生政策研究, 2022, 15(6): 17-23.
[12]赵华婷, 颜建周, 邵蓉. 法国临床效益评价对我国创新药医保目录动态调整的启示[J]. 中国卫生经济, 2019, 38(5): 94-96.
[13]艾丹丹, 陈辰, 吴婷婷, 等. 价值医疗背景下创新药品的定价和支付模式综述[J]. 中国卫生经济, 2020, 39(3): 77-79.
[14]王恩楠, 朱铭来. 我国专利药品医疗保险价格谈判的演化博弈研究[J]. 中国卫生政策研究, 2023, 16(2): 44-51.
[15]谭清立. 医保谈判政策对生物医药企业创新投入的影响机制分析[J]. 科技管理研究, 2025, 45(3): 120-127.
[16]吕倩鹏, 吴红, 刘智勇. 政策工具视角下我国创新药物研发政策量化研究[J]. 中国卫生事业管理, 2024, 41(12): 1393-1399.
[17]刘仁济, 杨得前, 许露. 政策工具视角下的中国科技成果转化政策变迁[J]. 科研管理, 2025, 46(9): 126-135.
[18]宋娇娇, 徐芳, 孟溦. 中国科技评价政策的变迁与演化：特征、主题与合作网络[J]. 科研管理, 2021, 42(10): 11-19.
[19]Casilli G, Lidonnici D, Jommi C, et al. Do France, Germany, and Italy agree on the added therapeutic value of medicines?[J]. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 2023, 39(1): e54.
[20]Garau M, Hampson G, Devlin N, et al. Applying a multicriteria decision analysis (MCDA) approach to elicit stakeholders’ preferences in Italy: The case of obinutuzumab for rituximab-refractory indolent non-Hodgkin lymphoma (iNHL)[J]. PharmacoEconomics Open, 2018, 2(2): 153-163.
[21]Kållberg C, Mathiesen L, Gopinathan U, et al. The role of drug regulatory authorities and health technology assessment agencies in shaping incentives for antibiotic R&D: A qualitative study[J]. Journal of Pharmaceutical Policy and Practice, 2023, 16: 53.
[22]Mundy L, Forrest B, Huang L Y, et al. Health technology assessment and innovation: Here to help or hinder?[J]. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 2024, 40(1): e37.
[23]李梦颖, 伍琳, 王昕妍, 等. 我国医保谈判药品落地问题的多重制度逻辑分析与政策建议[J]. 中国药房, 2024, 35(14): 1683-1689.
[24]蔡乾和, 陶蕊, 张一粟, 等. 公共科技成果价值评价的理论基础构建[J]. 科技管理研究, 2023, 43(3): 53-59.
[25]He A J, Bali A S, Ramesh M. Active stewardship in healthcare: Lessons from China’s health policy reforms[J]. Social Policy & Administration, 2022, 56(6): 925-940.
[26]Guo W, Wang P, Zhang Y, et al. Health technology assessment in China’s health care sector: Development and applications[J]. Health Systems & Reform, 2023, 9(3): 2327099.
[27]马文聪, 叶阳平, 陈修德. 创新政策组合：研究述评与未来展望[J]. 科技进步与对策, 2020, 37(15): 152-160.
[28]国家药品监督管理局. 化学药品注册分类及申报资料要求[Z]. 2020.
[29]国家医疗保障局. 基本医疗保险用药管理暂行办法: 国家医疗保障局令第1号[Z]. 2020.
[30]国家卫生健康委办公厅. 药品临床综合评价管理指南（2021年版 试行）: 国卫办药政发〔2021〕16号附件[Z]. 2021.
[31]中共中央办公厅, 国务院办公厅. 关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见[EB/OL]. (2017-10-08)[2026-10-31]. https://app.www.gov.cn/govdata/gov/201710/08/413100/article.html.
[32]Thornton P H, Ocasio W. Institutional logics[M]//Greenwood R, Oliver C, Sahlin K, et al. The SAGE handbook of organizational institutionalism. London: SAGE, 2008: 99-129.
[33]Ocasio W. Towards an attention-based view of the firm[J]. Strategic Management Journal, 1997, 18(S1): 187-206.
[34]练宏. 注意力分配——基于跨学科视角的理论述评[J]. 社会学研究, 2015, 30(4): 215-241+246.
[35]曾润喜, 莫敏丽. 政府注意力的测量: 路径、内容与展望[J]. 华中科技大学学报（社会科学版）, 2023, 37(1): 66-73.

[36]文宏. 中国政府推进基本公共服务的注意力测量——基于中央政府工作报告（1954—2013）的文本分析[J]. 吉林大学社会科学学报, 2014, 54(2): 20-26+171.
[37]陈星平, 毕利娜, 吴道友. 中国政府推进科技人才创新创业的注意力测量——中央政府工作报告（1978—2017）文本分析[J]. 科技进步与对策, 2018, 35(23): 155-160.
[38]Rogge K S, Reichardt K. Policy mixes for sustainability transitions: An extended concept and framework for analysis[J]. Research Policy, 2016, 45(8): 1620-1635.
[39]国家医疗保障局. 国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整常用问答（2026 年版）[Z]. 2026.
[40]Grimmer J, Stewart B M. Text as data: The promise and pitfalls of automatic content analysis methods for political texts[J]. Political Analysis, 2013, 21(3): 267-297.
[41]Gilardi F, Alizadeh M, Kubli M. ChatGPT outperforms crowd workers for text-annotation tasks[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2023, 120(30): e2305016120.
[42]Cohen J. A coefficient of agreement for nominal scales[J]. Educational and Psychological Measurement, 1960, 20(1): 37-46.
[43]Landis J R, Koch G G. The measurement of observer agreement for categorical data[J]. Biometrics, 1977, 33(1): 159-174.
[44]Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences[M]. 2nd ed. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1988.
[45]Field C A, Welsh A H. Bootstrapping clustered data[J]. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology), 2007, 69(3): 369-390.
[46]国家药品监督管理局药品审评中心. 创新药研发期间风险管理计划撰写技术指导原则（试行）: 国家药监局药审中心通告 2025 年第 38 号附件[Z]. 2025.
[47]国家药品监督管理局. 真实世界证据支持药物研发与审评的指导原则（试行）[Z]. 2020.
[48]国家药品监督管理局, 国家卫生健康委员会. 药物临床试验质量管理规范（2026 年修订）[Z]. 2026.
[49]国家医疗保障局. 谈判药品续约规则[EB/OL]//国家医疗保障局. 国家医疗保障局发布《2026 年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整工作方案》等相关文件: 附件 3. (2026-05-31)[2026-10-19]. https://www.nhsa.gov.cn/art/2026/5/31/art_109_20816.html.
[50]国家卫生健康委. 关于开展药品使用监测和临床综合评价工作的通知: 国卫药政函〔2019〕80 号[EB/OL]. (2019-04-09)[2026-10-21]. https://www.nhc.gov.cn/yaozs/c100097/201904/6bc8f273684845d3ab76fed841eb42d2.shtml.
[51]国家药品监督管理局药品审评中心. 以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则[Z]. 2021.
[52]国家医疗保障局. 国家医保局发布《参照药预沟通办法（试行）》 [EB/OL]. (2026-02-10)[2026-10-08]. https://www.nhsa.gov.cn/art/2026/2/10/art_109_19642.html.
[53]国务院办公厅. 关于健全药品价格形成机制的若干意见: 国办发〔2026〕9 号[EB/OL]. (2026-04-14)[2026-10-31]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202604/content_7065542.htm.
[54]国家医疗保障局办公室. 关于开展真实世界医保综合价值评价试点工作的通知: 医保办发〔2025〕15 号[EB/OL]. (2025-09-23)[2026-10-08]. https://www.nhsa.gov.cn/art/2025/9/23/art_109_17984.html.

作者简介：王孝炯（1982—，通信作者），男，安徽合肥人，博士研究生，中国科学院科技战略咨询研究院创新研究员，主要研究方向为创新发展政策；陈海婷（2002—），女，福建建瓯人，硕士研究生，主要研究方向为科技创新管理与政策；刘中全（1988—），男，河南郸城人，硕士研究生，国家发展改革委创新驱动发展中心处长、副研究员，主要研究方向为生物经济、生物医药、生物制造及未来产业、科技创新政策等。